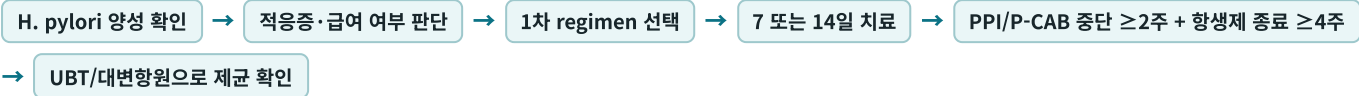


헬리코박터(*H. pylori*) 치료 치트시트

외래·내시경실용. 제균 적응증, 급여 기준, regimen, 제균 확인 일정을 한 장에 정리. [사용자 보강 + 가이드라인 보강] 급여 기준 확인일: 2026-08-04 (건강보험심사평가원 고시 기준. 향후 고시 개정 시 처방 시점에 재확인 필요).



이론적 배경: 감염 경로와 한국·일본의 특수성

감염 경로

경로	내용
인-인 전파	주로 소아기(가족 내, 특히 모-자간) 감염이 대부분. 성인 신규 감염은 드물.
경구-경구	구토물·침 등을 통한 전파. 어린 시절 밀접 접촉이 핵심.
분변-경구	위생 환경이 나쁜 환경에서 주요 경로. 물·음식 매개 가능.
위-경구	구토 시 위 내용물을 통한 전파.

감염 후 자연사: 한번 위에 정착하면 자연 치유되지 않고 만성 감염이 됨. 대부분 무증상이지만 시간이 지나며 위축성 위염 → 장상피화생 → 이형성 → 위암 (Correa cascade)으로 진행할 수 있어 고위험 인구에서 제균의 근거가 됨.

한국·일본 vs 다른 나라

항목	한국·일본	서구 선진국
유병률	역사적으로 높았으나 지속 감소. 한국 약 40-50%(과거 60-70%), 일본은 연령·출생코호트별 큰 차이(고령층 높고 젊은층 급감)	20-40% 수준
위암 위험	세계 최고 수준의 위암 발생률. 제균으로 위암 위험·재발을 낮추는 근거가 한국·일본 연구에서 강함	상대적으로 낮음
항생제 내성	클라리스로마이신 내성률 높음(한국 17.8%→33.3%로 상승). 내성검사·비스무트 4제 필요성 큼	지역별 차이
재감염률	선진국 수준으로 감소 추세(아래 재발·재감염 표 참조)	낮음(연 1% 안팎)

재발(recrudescence) vs 재감염(reinfection)

구분	정의	특징
재발(재활성화)	제균이 실패했으나 일시적으로 검출되지 않았던 균이 다시 증식	주로 제균 후 1년 이내에 발생. 군주가 동일한 경우가 많음.
재감염	제균 성공 후 새로운 감염	주로 제균 후 1년 이후, 특히 초기 2년에 집중. 고유병률 지역에서 흔함.

임상적 의미: 1년 이내 양성이면 재발(제균 실패)일 가능성이 높아 다른 regimen이 필요하고, 이후 양성이면 재감염 가능성이 높아 초기 regimen 재사용이 가능할 수 있음.

한국·일본의 재발·재감염률

지표	한국	일본
연간 재감염률	최신 대규모 연구 0.91-3.9%/년 . 과거 연구(1990-2000년대)는 9-13%/년까지 보고되었으나 감소 추세	0.2-2%/년 수준으로 매우 낮음
특징	제균 후 초기 24개월에 재감염 집중(5.9%/인년), 이후 2.0-2.4%로 감소	유병률 자체가 급감하여 재감염도 낮음
재발률	제균 후 1년 내 재발 1.8-9.3% 보고(치료 regimen·연구에 따라 상이)	—

해석: 한국·일본은 과거 고유병률 국가였으나 위생 환경 개선과 대규모 제균으로 유병률·재감염률이 지속 감소 중임. 다만 위암 위험이 여전히 높아 제균의 질 환부담 감소 효과가 크고, 이것이 적극적 제균·surveillance의 배경임.

제균 적응증(한국)

적응증	권고·급여
소화성궤양(반흔 포함)	강력 권고 급여
저등급 MALT 림프종	강력 권고 급여
조기위암 내시경 절제 후	강력 권고 급여
특발성 혈소판감소성 자반증(ITP)	강력 권고 급여
위선종 내시경절제술 후	조건부 권고 급여(2022.5.1~)
위축성 위염·장상피화생, 위암 1급 친족 가족력, 기능성 소화불량, 과증식성 용종 등	조건부 권고 전액본인부담(100/100)

보험·급여 기준(확인일: 2026-08-04, 심평원 고시): 급여는 소화성궤양(반흔 포함)·저등급 MALT 림프종·조기위암 절제 후·ITP·위선종 내시경절제술 후(2022.5.1~)이고, 위암 1급 친족 가족력·위축성 위염·환자 동의 등은 전액본인부담(100/100)임. 급여·100/100 모두 HP 검사 결과를 특정내역(JX999/MX999)에 기재하고, 제균 후 **UBT**는 **급여**로 인정됨. 비스무트 4제 사용 시 bismuth도 위 급여 적응증에서 급여 인정됨. 향후 고시 개정 시 처방 시점에 재확인 필요.

진단·제균 확인 검사

상황	권장 검사	메모
초기 진단 (비침습)	UBT, 대변항원검사	PPI/P-CAB 중단 2주, 항생제·비스무트 중단 4주 후 시행 권장
내시경 시행 시	CLO test, 조직검사	내시경 필요 환자에서 유용. 위음성 주의
제균 확인	UBT 또는 대변항원	항생제·비스무트 종료 ≥4주 + PPI/P-CAB 중단 ≥2주 후. UBT는 급여 인정
반복 실패·재치료 전	클라리스로마이신 내성검사(PCR)	맞춤 치료(tailored) 선택에 활용. 급여 적응증 확인

휴약 없이 검사하면 위음성 주의: 제균 확인 전 PPI/P-CAB·항생제 복용 상태를 반드시 기록하고 간격을 지킴.

치료 regimen (한국 지침 기반)

1차 · 표준 PPI/P-CAB 3제요법, 7-14일
PPI(표준용량) bid 또는 P-CAB + amoxicillin 1,000 mg bid + clarithromycin 500 mg bid
주의 클라리스로마이신 내성률이 높은 지역에서는 실패 위험 큼. 내성검사(tailored) 또는 4제 고려. 14일이 7일보다 성공률 높음.

1차 · 경험적 대안 비스무트 4제요법, 14일
PPI bid + bismuth 120 mg qid + metronidazole 500 mg tid + tetracycline 500 mg qid
내성률 높은 지역에서 경험적 1차로 선택 가능. 구제치료를 위해 아껴두는 전략도 있음.

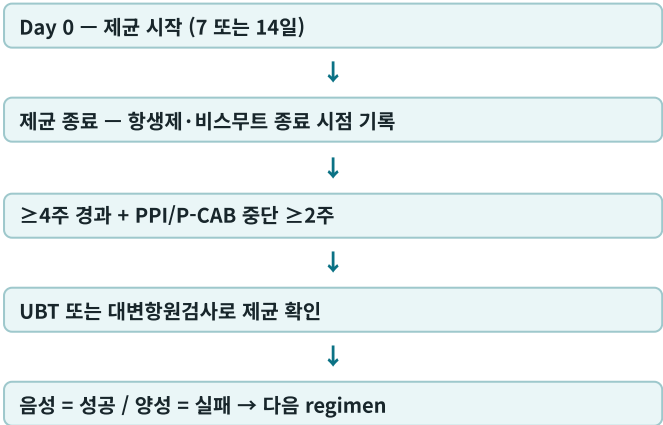
처방 팁: 같은 항생제를 반복하지 않기. 이전 제균 실패 regimen을 기록에 남기고, 내성 가능성이 높은 환자는 처음부터 비스무트 4제 또는 맞춤 치료 고려. 순차요법은 현 지침에서 제외됨. 제균요법 투여일수는 7일 기본, **14일 처방도 인정됨**.

2차 · 표준 구제 비스무트 4제요법, 14일
1차 3제 실패 후 2차 구제로 강력 권고(권고 강도: 강함, 근거 높음).

3차 레보플록사신 3제요법, 10-14일
PPI bid + levofloxacin 500 mg qd + amoxicillin 1,000 mg bid. 비스무트 4제 실패 후 고려(약한 권고). **3차 제균요법으로 10-14일 투여 시 급여 인정.**

Tailored 내성검사 기반 맞춤 치료
클라리스로마이신 내성(-) → 3제 가능 / 내성(+) → 비스무트 4제 등 내성 무관 regimen. P-CAB 기반 regimen도 PPI 대안으로 인정.

제균 확인 타임라인



처방 전 체크리스트

확인 항목	기록
이전 제균 치료력·사용 항생제	내성 추정, 같은 약제 재사용 회피
페니실린 알레르기	amoxicillin 대체 regimen 필요(내성검사·전문 의 상담)
임신 가능성	tetracycline·levofloxacin-bismuth 금기. 치료 시기 조정
Clarithromycin 상호작용	statin(시마·로바스타틴), warfarin 등 병용약 확인
Metronidazole 주의	복용 중 및 종료 후 수일간 금주 지도(disulfiram 유사 반응)